

AIX-MARSEILLE UNIVERSITÉ

FACULTÉ DE droit

ET DE SCIENCE POLITIQUE

DROIT ADMINISTRATIF

Licence 2 Droit – division A – 2nd semestre

TRAVAUX DIRIGÉS LA RESPONSABILITÉ ADMINISTRATIVE EN MATIÈRE HOSPITALIÈRE

Équipe pédagogique :

Chargé de cours :

M. Frédéric LAURIE, Maître de conférences

Chargés de travaux dirigés :

Mmes Mathilde HEYRAL et Louise MAUROUARD et MM. MM. Noel MPOTO OKANDJO,
Sylvain REY, Teddy Junior CROZATIER, Thibault GAUTIER et Thomas PIOT

ANNÉE UNIVERSITAIRE 2025-2026

THÈMES DES SÉANCES DE TRAVAUX DIRIGÉS

1. Méthodologie
2. La notion de juridiction administrative
3. L'intégration des traités internationaux et européens parmi les sources de la légalité
4. L'invocabilité du droit dérivé de l'Union européenne devant le juge administratif
5. Les actes administratifs insusceptibles de recours
6. L'étendue du contrôle du juge de l'excès de pouvoir
7. Colle « blanche »
8. Les pouvoirs du juge administratif en matière contractuelle
9. **La responsabilité administrative en matière hospitalière**

1 – Cas pratique

1) Hôpital public de Catastrophe-en-Provence

M. Râf, médecin cardiologue à l'hôpital public de Catastrophe-en-Provence et chef du service réanimation, est peu apprécié par les autres membres du service. La raison ? Sa nonchalance et son manque de sérieux dans tout ce qu'il peut entreprendre dans le cadre de son travail.

Le 23 mars 2026, alors qu'un patient est soudainement victime d'une crise cardiaque, il est rapidement transféré dans le service de M. Râf. Ce dernier n'est pourtant pas présent alors même qu'il n'avait pas posé de congés pour pallier à sa possible absence. Pire encore : personne n'est au courant d'où est-ce qu'il pourrait se trouver actuellement. Le service commence malgré tout à réaliser certaines opérations afin de sauver la victime en l'absence de toute direction par le cardiologue.

Celui-ci finit par arriver non sans une dizaine de minutes de retard expliquant qu'il était en train de faire « une petite pause café » et qu'il avait volontairement laissé son téléphone portable de service dans son bureau afin qu'« on le laisse enfin tranquille ». Cette action a eu pour conséquence de le rendre injoignable en cas d'urgence. Prenant de nouveau les choses en main, il ordonne aux agents du service d'augmenter le taux des décharges électriques à un niveau que certains jugent trop important au vu de l'état du patient : son diagnostic précise bien qu'en raison de malformation musculaire, une exposition à des décharges électriques de trop haute intensité risquerait d'avoir des effets irréversibles sur le patient. M. Râf n'en tient pas compte et ordonne l'augmentation du taux des décharges. A son réveil, le patient se retrouve intégralement paralysé de la jambe gauche.

Question 1 : quel régime de responsabilité invoquer en l'espèce ? Devant quelle juridiction le patient pourra-t-il demander réparation ?

Une semaine après les faits, M. Râf commence à recevoir régulièrement des messages de menace sur son téléphone personnel faisant référence aux derniers événements. L'un des messages mentionne même l'adresse du domicile de M. Râf. La situation prend un autre tournant quand il retrouve sa voiture intégralement vandalisée, les vitres et les phares brisés avec une menace de mort taguée sur son véhicule. Craignant pour son intégrité physique, il demande à l'établissement hospitalier la mise en place d'une protection fonctionnelle. Le directeur d'hôpital, M. Carmah, conscient du comportement répété du directeur de service, lui refuse cette protection en lui expliquant qu'il est grand temps que le médecin cardiologue assume ses actes.

Question 2 : l'hôpital peut-il refuser à son agent la protection fonctionnelle ?

2) Hôpital psychiatrique de Ville-Paumée-en-Provence

Dans l'hôpital psychiatrique de Ville-Paumée-en-Provence, M. Negado, un patient interné pour cause de troubles mentaux et notamment pour psychose depuis quelques années, est sous la surveillance obligatoire d'au moins un membre du personnel hospitalier. Ses crises psychotiques le poussant quasi systématiquement à chercher à s'échapper de l'établissement.

Alors qu'une dispute entre deux patientes explose dans le jardin de l'hôpital, l'agent chargé de la surveillance de M. Negado laisse temporairement ce dernier pour aller séparer les deux femmes.

Le patient psychotique saisit alors sa chance et court en direction du portail d'entrée des véhicules situés non loin du jardin. Trop occupé à régler la violente dispute entre les deux patientes, l'agent ne se rend compte de rien.

Escaladant le portail qui n'est bizarrement pas gardé, M. Negado s'échappe de l'hôpital et part en direction du parc municipal se trouvant de l'autre côté de la route. Une fois arrivé, il découvre la splendide fontaine des quatre baleineaux et n'hésite pas une seconde à se baigner dedans. Dans l'euphorie de sa baignade, il s'assomme avec le goulot d'un des tubes de la fontaine et se retrouve la tête la première dans l'eau, inconscient. Restant quelques minutes noyé, des individus qui passaient devant la fontaine le sortent rapidement de l'eau. Il est finalement ramené à l'hôpital psychiatrique dans lequel il est ausculté : suite à sa noyade, le médecin lui découvre un œdème cérébral. Dans les jours qui suivent, de nombreux membres du personnel médical se rendent également compte que M. Negado se plaint très régulièrement de migraines, chose qui ne lui arrivait pas avant. Les agents pensent que ces maux de tête sont probablement liés à des séquelles neurologiques dues à la noyade.

En visite exceptionnelle, la mère de M. Negado découvre ce qui est arrivé à son fils et décide d'engager la responsabilité de l'hôpital psychiatrique.

Question : sur quelle(s) faute(s) pensez-vous qu'il serait possible d'engager la responsabilité de l'hôpital ?

3) CHU d'Incompétence-sur-Durance

Mme Padchance, une agente immobilière, subit, lors d'un trajet en voiture vers son lieu de travail, un grave accident de la route dans lequel elle est victime de plusieurs blessures : les muscles de sa jambe droite sont gravement touchés et elle perd une quantité abondante de sang au niveau de l'abdomen. De même, les éclats de verre dus à l'accident lui ont balaféré une grande partie du visage. Elle est emportée au service d'urgences du CHU d'Incompétence-sur-Durance puis traitée rapidement à l'abdomen et à la jambe. Son état stabilisé, le chef du bloc opératoire lui explique profiter de l'occasion pour procéder à des opérations de chirurgie réparatrice au niveau de son visage afin de s'occuper des différentes cicatrices. Le diagnostic précisant bien que les blessures subies au visage, bien que n'engageant pas directement l'état de santé de Mme Padchance, justifient une intervention aussi rapide que possible.

Lors de l'opération de chirurgie, un laser est utilisé pour mettre en évidence les cicatrices mais en raison d'une surchauffe du générateur électrique de l'hôpital, la chaleur du laser augmente rapidement et devient telle que Mme Padchance est brûlée au quatrième degré : les muscles de la mâchoire de la patiente sont directement touchés et sa peau légèrement brûlée. La scène semble tout droit sortie d'un film de science-fiction et pourtant cela a pour effet de causer une douleur intense à la victime, amplifiant par la même occasion l'état de la blessure au visage qui devait initialement être traitée.

Furieuse de se retrouver dans un tel état, Mme Padchance souhaite engager la responsabilité de l'hôpital pour lui avoir causé un dommage particulièrement grave alors même qu'elle ne s'attendait pas à cela pour une opération de chirurgie réparatrice.

Le directeur d'hôpital, M. Pamafole est désespéré : il explique qu'il était impossible de deviner qu'une surchauffe du générateur conduirait à faire augmenter d'une telle façon la chaleur dégagée par un simple laser. D'autant plus que Mme Padchance est la seule victime recensée de tout l'hôpital.

Question : qu'en pensez-vous ?

2 – Documents

1. Sur le principe même de la responsabilité des hôpitaux

1.1. La responsabilité

1.1.1 La responsabilité hospitalière

Article L. 1142-1 du code de la santé publique

I. I. Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.

Les établissements, services et organismes susmentionnés sont responsables des dommages résultant d'infections nosocomiales, sauf s'ils rapportent la preuve d'une cause étrangère.

II. II. Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.

Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret.

1.1.2 La responsabilité personnelle

CE, Sect., 26 avril 1963, Centre Hospitalier de Besançon, req. n° 42783

CONSIDÉRANT qu'il résulte de l'instruction que, par des décisions judiciaires passées en force de chose jugée, le sieur X, chirurgien du Centre hospitalier régional de Besançon, a été condamné pour faute professionnelle commise dans l'exercice de ses fonctions à payer au sieur Y la somme de 4.102.826 anciens francs en réparation de la totalité du préjudice subi par son fils mineur du fait de son hospitalisation, le 12 août 1950, dans l'établissement précité ; qu'à la suite de cette condamnation, les héritiers du sieur X et la Société médicale d'assurances

« Le Sou Médical », son assureur, ont adressé à la commission administrative du Centre hospitalier régional le 20 octobre 1955 une demande d'indemnité en réparation du préjudice résultant pour eux de la condamnation dont s'agit ; que, par un jugement en date du 21 juin 1957, le Tribunal administratif de Besançon, faisant droit à la demande du sieur X et de la Société « Le Sou Médical » — laquelle, en qualité d'assureur du sieur X, avait intérêt et, par suite, était recevable à former une telle action — a condamné le centre hospitalier régional à leur payer la somme susmentionnée de 4.102.826 anciens francs avec les intérêts de droit ; que la requête susvisée du Centre hospitalier régional de Besançon tend à l'annulation de ce jugement et à la décharge de ladite condamnation ;

Sur l'exception tirée de la déchéance quadriennale :

Cons. qu'aux termes de l'article 148 de la loi du 31 décembre 1945: « sont prescrites et définitivement éteintes au profit de l'Etat, des départements, des communes et des établissements » publics, sans préjudice des déchéances prononcées par des lois antérieures ou consenties par des marchés et conventions, toutes créances qui, n'ayant pas été acquittées avant la clôture de l'exercice auquel elles appartiennent, n'auraient pu être liquidées, ordonnancées et payées dans un délai de quatre années à partir de l'ouverture de l'exercice pour les créanciers domiciliés en Hampe et de cinq années pour les créanciers domiciliés hors du territoire européen » ;

Cons. que la créance éventuelle des consorts X et de la Société « Le Sou Médical » ne saurait se rattacher, contrairement à ce que soutient le Centre hospitalier de Besançon, à l'exercice 1950 au cours duquel le jeune Ya été hospitalisé ; qu'elle n'a trouvé son origine que dans la condamnation prononcée par les tribunaux judiciaires à l'encontre du sieur X et ne pouvait être liquidée au plus tôt, avant l'intervention de l'arrêt en date du 31 mai 1954 par lequel la Cour d'appel de Besançon a fixé à 4.102.826 anciens francs l'indemnité due par le docteur X au père de la victime ; que des lors c'est à bon droit que le tribunal administratif, s'il a admis la recevabilité des conclusions du président de la commission administrative de l'établissement, compétent pour opposer à toute époque devant la juridiction administrative la déchéance prévue par les dispositions précitées, a déclaré que la demande d'indemnité formée par les consorts X et la Société « Le Sou Médical » n'était pas atteinte par ladite, déchéance ;

CE, 4 juillet 1990, Société d'assurances Le Sou médical, req. n° 63930

Considérant que le choix d'assurer la nuit le service de garde de chirurgie à domicile et non au sein de l'établissement ne constitue pas une faute dans l'organisation du service public hospitalier ; qu'aucune faute n'a été commise tant lors de l'admission de Mme X... à l'hôpital que dans la surveillance et les soins qui lui ont été donnés dans la nuit du 28 au 29 novembre 1977 par l'interne de garde au service des urgences ; que le dommage est imputable au refus de M. Z... de se rendre au chevet de la patiente et de pratiquer sur celle-ci les actes chirurgicaux qui lui incombait ; qu'eu égard à la nature et à la gravité de la faute personnelle ainsi commise, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a laissé à M. Z... l'entière charge des condamnations prononcées au pénal et a rejeté la demande de cette société ; (...)

CE, 28 décembre 2001, Valette, req. n° 213931

Considérant, en troisième lieu, qu'il ressort des pièces du dossier que M M, accueilli le 29 juillet 1996 dans le service de radiologie dirigé par le Pr X afin d'y subir un examen scanographique, s'était vu, par erreur, injecter par un médecin de l'eau non stérile contenue dans une seringue ; que ce patient fut victime d'un choc septique nécessitant son admission au service de réanimation du centre hospitalier général de Lagny dans la nuit du 29 au 30 juillet ; que le 31 juillet l'intéressé fut transféré dans un état de détresse respiratoire aiguë à l'hôpital de la Pitié- Salpêtrière ; qu'il est constant que bien que le Dr X ait eu connaissance dès le 29 juillet de l'erreur médicale commise dans son service et qui était à l'origine du choc septique, ni la famille du patient, ni les praticiens ayant été amenés à lui dispenser des soins n'ont été informés de cette erreur avant le 31 juillet, et ce alors même que le Dr X ne pouvait ignorer la gravité de l'état de santé de M M ainsi que les recherches effectuées par les médecins du centre hospitalier de Lagny pour déterminer l'origine du choc septique qu'il avait subi ; que ce n'est que le 1er août que le Dr X a porté à la connaissance des médecins réanimateurs du centre hospitalier de La Pitié-Salpêtrière l'erreur commise dans son service ; qu'eu égard au caractère

inexcusable du comportement de ce praticien au regard de la déontologie de la profession, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris a fait une exacte application des dispositions précitées de l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 en estimant qu'il avait commis une faute personnelle, et ce alors même que les faits reprochés avaient été commis dans le cadre du service et qu'ils auraient pu être invoqués par M. M à l'appui d'une action en responsabilité engagée devant la juridiction administrative à l'encontre de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris ;

1.1.3. La protection fonctionnelle

TA Toulouse, 13 juin 2007, req. n° 0402402

C'est à tort qu'un hôpital a refusé de rembourser les frais d'avocat engagés par un praticien hospitalier poursuivi pour des négligences et des fautes commises lors d'un accouchement, ces faits ne pouvant être regardés comme constituant des fautes personnelles détachables des fonctions.

CE, 20 mai 2016, Hôpitaux civils de Colmar, req. n° 387571

Considérant que la circonstance qu'un agent soit susceptible de bénéficier de la protection de la collectivité qui l'emploie pour obtenir réparation d'un préjudice qu'il estime avoir subi ne fait pas obstacle à ce qu'il recherche, à raison des mêmes faits, la responsabilité pour faute de cette collectivité ;

1.2. La faute

1.2.1. La faute lourde

CE, Sect., 8 novembre 1935, Dame Philipponeau, req. n° 31999.

Vu la requête présentée pour la dame X..., autorisée par son mari, demeurant..., et tendant à ce qu'il plaise au Conseil annuler une décision implicite de rejet résultant du silence gardé pendant plus de quatre mois par le directeur de l'Assistance publique de Paris, sur la demande d'indemnité formée par la requérante à raison du préjudice qu'elle a subi du fait du manque de soins dont elle aurait eu à se plaindre durant un séjour à l'hôpital Saint-Antoine;
Vu la loi du 24 mai 1872 ;

Considérant que pour demander à l'administration de l'Assistance publique de Paris l'allocation d'une indemnité, la requérante soutient que les affections dont elle a été atteinte postérieurement à sa sortie de l'hôpital Saint-Antoine seraient imputables à des fautes commises dans l'exercice de leurs fonctions par des membres du personnel dudit établissement ;

Cons. que l'intéressé ne justifie pas, d'une part, d'une faute commise par des agents du service administratif de l'hôpital et que, d'autre part, elle n'établit pas à la charge du service médical l'existence d'une faute lourde dans le traitement dont elle a été l'objet; que, par suite, la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision attaquée ;...
(Rejet ; dépens mis à la charge de la requérante).

1.2.2. La réduction du domaine de la faute lourde

CE, Sect., 26 juin 1959, Rouzet, req. n° 31396.

« Considérant qu'il résulte de l'instruction que le préjudice corporel subi par la jeune Christine Rouzet est la conséquence directe d'une faute commise par un interne de l'hôpital des enfants malades, à Paris, qui, par erreur, a pratiqué une perfusion intraveineuse dans une artère ; qu'une telle intervention a, en principe, le caractère d'un acte de soins et ne figure pas au nombre des actes médicaux énumérés par les articles 3 et 4 de l'arrêté [du ministre de la Santé publique et de la population] du 31 décembre 1947 ; que si, en l'espèce, cette intervention présentait des difficultés particulières, eu égard au jeune âge de l'enfant et à la gravité de son état, son exécution, dans un service hospitalier spécialisé dans le traitement des maladies des très jeunes enfants, n'exigeait pas l'intervention ou la surveillance personnelle d'un médecin ; que, dans ces conditions et bien qu'elle n'ait pas présenté le caractère d'une faute lourde, la faute commise par l'interne susmentionné a été de nature à engager envers la victime la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ».

CE, 22 décembre 1976, Administration générale de l'Assistance Publique à Paris c. Derridj et CPAM de la région parisienne, req. n° 00848.

Considérant qu'il résulte du rapport de l'expert et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté par l'administration générale de l'assistance publique à Paris que la paraplégie des membres inférieurs dont la dame D. a obtenu réparation par le jugement attaqué est en relation directe de cause à effet avec l'injection intramusculaire pratiquée le 21 avril 1969 ; que, s'agissant d'un acte de soin courant et de caractère bénin, les troubles susmentionnés ne peuvent être regardés que comme révélant une faute commise dans l'organisation ou le fonctionnement du service.

1.2.3. L'abandon de la faute lourde

CE, 10 avril 1992, Époux V., req. n° 79027.

Sur le principe de la responsabilité :

Considérant que Mme V. a subi, le 9 mai 1979, quelques jours avant le terme de sa grossesse, à l'hôpital clinique du Belvédère à Mont-Saint-Aignan (Seine-Maritime), une césarienne pratiquée sous anesthésie péridurale ; qu'au cours de l'opération, plusieurs chutes brusques de la tension artérielle se sont produites, suivies d'un arrêt cardiaque ; que Mme V. a pu être réanimée sur place, puis soignée au centre hospitalier régional de Rouen, où elle a été hospitalisée jusqu'au 4 juillet 1979 ; qu'elle demeure atteinte d'importants troubles neurologiques et physiques provoqués par l'anoxie cérébrale consécutive à l'arrêt cardiaque survenu au cours de l'intervention du 9 mai 1979 ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction et, notamment, de l'ensemble des rapports d'expertise établis tant en exécution d'ordonnances du juge d'instruction que du jugement avant-dire-droit du tribunal administratif de Rouen en date du 4 avril 1986, que la césarienne pratiquée sur Mme V. présentait, en raison de l'existence d'un placenta praevia décelé par une échographie, un risque connu d'hémorragie pouvant entraîner une hypotension et une chute du débit cardiaque ; qu'il était par ailleurs connu, à la date de l'intervention, que l'anesthésie péridurale présentait un risque particulier d'hypotension artérielle ;

Considérant que le médecin anesthésiste de l'hôpital a administré à Mme V., avant le début de l'intervention, une dose excessive d'un médicament à effet hypotenseur ; qu'une demi-heure plus tard une chute brusque de la tension artérielle, accompagnée de troubles cardiaques et de nausées a été constatée ; que le praticien a ensuite procédé à l'anesthésie péridurale prévue et a administré un produit anesthésique contre indiqué compte tenu de son effet hypotenseur ; qu'une deuxième chute de la tension artérielle s'est produite à onze heures dix ; qu'après la césarienne et la naissance de l'enfant, un saignement s'est produit et a été suivi, à onze heures vingt-cinq, d'une troisième chute de tension qui a persisté malgré les soins prodigués à la patiente ; qu'à douze heures trente, du plasma décongelé mais insuffisamment réchauffé a été perfusé provoquant immédiatement une vive douleur suivie de l'arrêt cardiaque ;

Considérant que les erreurs ainsi commises, qui ont été selon les rapports d'expertise la cause de l'accident survenu à Mme V., constituent une faute médicale de nature à engager la responsabilité de l'hôpital ; que par suite, M. et Mme V. sont fondés à demander l'annulation du jugement attaqué du 4 avril 1986 en tant que par ce jugement, le tribunal administratif de Rouen a rejeté les conclusions de M. et Mme V. ;

1.2.4. La faute simple

CE, 9 nov. 2018, Assurances du crédit mutuel IARD, req. n° 412799.

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. C..., alors hospitalisé à la demande d'un tiers au sein du centre hospitalier spécialisé Charcot de Caudan en raison de l'affection mentale dont il était atteint, a, le 30 novembre 2007 vers 17 heures, quitté le centre hospitalier sans autorisation et a été heurté vers 18 heures par un véhicule automobile conduit par M. A... sur la route départementale n° 769. La société d'assurance ACM IARD, assureur du conducteur du véhicule impliqué, a, en application des dispositions de la loi du 5 juillet 1985, indemnisé M. C... des dommages corporels subis par lui et remboursé à la caisse primaire d'assurance maladie du Morbihan les débours exposés pour lui. Estimant toutefois que le centre hospitalier Charcot avait manqué à son obligation de surveillance à l'égard de M. C..., elle a ensuite demandé à être indemnisée par cet établissement. Par un arrêt du 24 mai 2017, contre lequel la société ACM IARD se pourvoit en cassation, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé le jugement du 11 juin 2015 par lequel le tribunal administratif de Rennes avait condamné le centre hospitalier Charcot à verser à cette société la somme de 109 074,84 euros et rejeté sa demande indemnitaire.

2. Le conducteur d'un véhicule terrestre à moteur, impliqué dans un accident de la circulation dont il a indemnisé la victime en application des articles 2 et suivants de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l'amélioration de la situation des victimes d'accidents de la circulation et à l'accélération des procédures d'indemnisation, ou son assureur subrogé, peut exercer un recours contre un co-auteur n'ayant pas la qualité de conducteur ou de gardien d'un tel véhicule, selon les conditions du droit commun, dans la limite de la part de responsabilité encourue par ce dernier à l'égard de la victime. A ce titre, lorsque la victime était hospitalisée sans son consentement, le conducteur ou son assureur ne peut rechercher la responsabilité de l'établissement de santé que si celui-ci a commis une faute permettant à son patient de quitter l'établissement et si, de ce fait, le comportement de celui-ci a concouru à l'accident.

3. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond, d'une part, que la présence de M. C... sur la route départementale, sans laquelle l'accident ne se serait pas produit, était due au défaut de surveillance du centre hospitalier spécialisé Charcot, dont M. C..., hospitalisé à la demande d'un tiers, était sorti sans autorisation une heure plus tôt, et, d'autre part, que celui-ci

s'est engagé sur la chaussée à la tombée de la nuit, en dehors de tout passage protégé, en dépit de la circulation des véhicules. Par suite, en jugeant que les préjudices et débours dont la société ACM IARD avait assumé la réparation avaient pour seule origine, sans que le fait de la victime y ait aucune part, la faute commise par son assuré, conducteur du véhicule qui avait renversé M.C..., et qu'il n'existait ainsi aucun lien de causalité direct entre ces préjudices et le défaut de surveillance susceptible d'être imputé au centre hospitalier spécialisé, la cour a inexactement qualifié les faits de l'espèce.

CE, 5 janvier 2000, Consorts Telle et AP-HP, req. n° 181899.

Considérant que lorsque l'acte médical envisagé, même accompli conformément aux règles de l'art, comporte des risques connus de décès ou d'invalidité, le patient doit en être informé dans des conditions qui permettent de recueillir son consentement éclairé ; que, si cette information n'est pas requise en cas d'urgence, d'impossibilité, de refus du patient d'être informé, la seule circonstance que les risques ne se réalisent qu'exceptionnellement ne dispense pas les praticiens de leur obligation ;

Considérant que, lors d'une intervention endovasculaire destinée à traiter par embolisation une malformation artérioveineuse, le micro-cathéter introduit dans l'artère cérébrale de M. T. s'est brisé, provoquant un accident ischémique à la suite duquel le patient est demeuré atteint d'une paralysie du bras et de la jambe gauches ; qu'en se fondant sur le caractère exceptionnel d'un tel accident pour juger qu'il n'y avait pas lieu d'informer le patient des risques de l'opération, la cour administrative d'appel de Lyon a commis une erreur de droit justifiant l'annulation de son arrêt ;

Considérant qu'aux termes de l'article 11 de la loi susvisée du 31 décembre 1987, le Conseil d'Etat, s'il prononce l'annulation d'une décision d'une juridiction administrative statuant en dernier ressort, peut "régler l'affaire au fond si l'intérêt d'une bonne administration de la justice le justifie" ; que, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de régler l'affaire au fond ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le traitement par embolisation, même effectué dans les règles de l'art, présente des risques de décès ou d'invalidité du patient, pouvant résulter notamment d'un accident ischémique consécutif à la rupture du micro-cathéter au moment de son retrait de l'artère dans laquelle il avait été introduit ; que ces risques doivent être portés à la connaissance du patient ;

Considérant que M. T. soutenait qu'il n'avait pas été informé des risques de l'intervention ; que les hospices civils de Lyon, qui n'ont contesté cette affirmation ni au cours des opérations d'expertise, ni devant le tribunal administratif ont produit en appel une attestation établie par un praticien postérieurement à l'intervention et aux termes de laquelle le patient avait été "informé des risques du traitement envisagé" ; que, dans les circonstances de l'espèce, un tel document n'est pas de nature à établir que les praticiens se sont acquittés de leur obligation d'information ; qu'ainsi, les hospices civils de Lyon ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal administratif a reconnu l'existence d'un manquement à cette obligation de nature à engager leur responsabilité ;

Considérant, toutefois, que la faute commise par les praticiens de l'hôpital n'a entraîné pour M. T. que la perte d'une chance de se soustraire au risque qui s'est réalisé ; qu'ainsi, c'est à tort que le tribunal administratif de Lyon, se fondant sur la faute résultant de l'absence d'information, a condamné les hospices civils de Lyon à réparer intégralement les conséquences dommageables de l'accident ;

Considérant qu'il appartient au Conseil d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens présentés par M. et Mme T. devant le tribunal administratif susceptibles de justifier la condamnation des hospices civils de Lyon à réparer intégralement les conséquences de l'accident ;

Considérant que le traitement par embolisation présente des risques connus de rupture du cathéter au moment de son retrait de l'artère dans laquelle il a été introduit, sans que cette rupture puisse être évitée, quelle que soit la qualité de l'opérateur et du matériel utilisé ; qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expert, que l'intervention s'est déroulée conformément aux règles de l'art et que, contrairement à ce que soutiennent les requérants, l'existence d'une faute médicale ou d'une faute dans l'organisation et le fonctionnement du service n'est pas établie ;

Considérant qu'il résulte du rapport d'expertise que la malformation artérioveineuse dont M. T. était atteint pouvait provoquer, à défaut de procéder à un traitement par embolisation, des céphalées plus ou moins invalidantes, des crises d'épilepsie, des hémorragies cérébrales entraînant la paralysie, voire le décès du patient ; que les séquelles d'hémiplégie consécutives à l'intervention ne peuvent donc être regardées comme sans rapport avec son état initial ou l'évolution prévisible de cet état ; que, par suite, la responsabilité sans faute des hospices civils de Lyon ne saurait être engagée ;

CE, 18 mars 2019, Mme B., req. n° 418458

1. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge de fond que Mme B..., qui avait été suivie pendant sa grossesse au centre hospitalier de Niort, a accouché le 21 février 2001. Son fils, Ivan Esterle, a progressivement présenté des troubles du comportement, qui se sont aggravés à compter de sa scolarisation en septembre 2004. Saisi à deux reprises par Mme B..., le juge des référés du tribunal administratif de Poitiers a diligenté deux expertises, confiées respectivement à un psychiatre et à un neurologue. Mme B... a ensuite saisi ce tribunal administratif d'une requête tendant à la condamnation du centre hospitalier de Niort à réparer les préjudices subis par elle-même et son fils du fait des troubles dont ce dernier est atteint, ainsi qu'à la réalisation d'une nouvelle expertise aux fins d'évaluer ces préjudices. Par un jugement du 16 juillet 2015, le tribunal a rejeté cette demande. Par un arrêt du 28 décembre 2017, la cour administrative d'appel de Bordeaux a rejeté l'appel formé par Mme B...contre ce jugement. Mme B...se pourvoit en cassation contre cet arrêt.

2. La cour administrative d'appel a relevé que dans une lettre du 4 juin 1999 adressée à l'ensemble des médecins en activité, l'Agence française de sécurité sanitaire des produits de santé a demandé que les femmes séropositives au virus de l'immunodéficience humaine soient informées du fait que l'absorption de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse exposait l'enfant à naître à un risque accru de développer des atteintes mitochondriales provoquant des troubles neurologiques. La cour a constaté que le centre hospitalier de Niort, qui avait connaissance de ce que Mme B...prenait un traitement antirétroviral en raison de sa séropositivité au virus de l'immunodéficience humaine, n'établissait pas avoir délivré à l'intéressée une telle information. Elle a cependant retenu, au vu des conclusions de l'expert neurologue et dans le cadre de son pouvoir souverain d'appréciation des faits, d'une part, que les troubles autistiques manifestés par le fils de la requérante ne permettaient pas de caractériser une maladie mitochondriale et, d'autre part, qu'il n'était pas établi que la prise de médicaments antirétroviraux pendant la grossesse aurait exposé l'enfant à naître à un risque accru de développer de tels troubles. En déduisant de ces éléments que le manquement du centre hospitalier à son obligation d'information n'était pas à l'origine d'une perte de chance d'éviter les préjudices dont la réparation était demandée, la cour n'a pas commis d'erreur de droit.

2. Sur la diversité des fautes reconnues

2. 1. La faute dans l'organisation et le fonctionnement du service

- **L'insuffisance dans la surveillance des patients et des locaux**

CE, 27 février 1985, Centre hospitalier de Tarbes, req. n° 39069-48793.

Considérant qu'il résulte de l'instruction que les tendances suicidaires de Mme X..., traitée depuis plusieurs années dans l'établissement, étaient connues du personnel soignant, et que Mme X... avait fait une première tentative de suicide quelques minutes après son arrivée dans ce service ; que, dans ces circonstances et bien qu'elle ait subi, une heure environ avant l'accident, de fortes injections de calmant, le fait qu'elle ait été laissée sans surveillance dans une chambre dépourvue de tout système de fermeture et qu'elle ait pu se jeter dans la cage d'escalier par une porte de service qui devait normalement rester ouverte pour des raisons de sécurité, révèle un défaut d'organisation du service de nature à engager la responsabilité de l'établissement ;

Considérant que de ce qui précède, il résulte que le centre hospitalier de Tarbes n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, en date du 27 octobre 1981, qui est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Pau l'a déclaré responsable des conséquences dommageables de l'accident survenu à Mme X... ;

- **Le mauvais fonctionnement du service**

CE, 16 novembre 1998, Mlle Y., req. n° 178585.

Considérant qu'il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise du professeur Di X..., que, malgré la persistance des douleurs ressenties par Mlle Z... les symptômes présentés par le mollet gauche de la blessée, le centre hospitalier de Brive n'a fait procéder que le 9 mars 1990 en fin d'après-midi, soit plus de quarante-huit heures après l'arrivée de Mlle Y... aux urgences de l'hôpital, à un examen par un chirurgien ; que le syndrome de la loge, diagnostiqué le 9 mars 1990, n'a pu être efficacement traité alors qu'un diagnostic rapide aurait conservé à la victime des chances de récupération totale ; qu'ainsi, le centre hospitalier de Brive n'est pas fondé à soutenir que l'absence d'examen rapide par un chirurgien, alors que l'intéressée était entrée en urgence à l'hôpital à la suite de chutes de cheval et souffrait de manière croissante des mollets et du genou, ne constituait pas une faute dans l'organisation du service de nature à engager sa responsabilité ; que la circonstance que le syndrome de la loge serait difficile à diagnostiquer par des praticiens généralistes n'ayant pas l'expérience de ce type de symptômes est sans influence sur l'existence de cette faute ; qu'il résulte de ce qui précède que le centre hospitalier de Brive n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du tribunal administratif de Limoges du 20 janvier 1994 ;

CE, 27 juin 2005, M. et Mme X., req. n° 250483.

Considérant qu'aux termes du second alinéa de l'article L. 369 du code de la santé publique devenu l'article L. 4151-3 : En cas d'accouchement dystocique (...) [les sages-femmes] (...) doivent faire appeler un médecin. ; qu'il résulte de ces dispositions que lorsque survient une dystocie pendant un accouchement se déroulant sous la surveillance d'une sage-femme, celle-ci a l'obligation d'appeler un médecin ; que l'absence d'un médecin dans de telles circonstances est constitutive d'un défaut dans l'organisation et le fonctionnement du service engageant la responsabilité du service public hospitalier, à moins qu'il ne soit justifié d'une circonstance d'extrême urgence ayant fait obstacle à ce que la sage-femme appelle le médecin ou que le médecin appelé ait été, pour des motifs légitimes, placé dans l'impossibilité de se rendre au chevet de la parturiente ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que Mme X a été admise le 13 juillet 1995 au centre hospitalier général de Pau et y a donné naissance à une fille pesant 4,550 kilos ; qu'est survenue pendant l'accouchement une dystocie des épaules ayant conduit la sage-femme présente à effectuer seule une manœuvre destinée à dégager les épaules de l'enfant ; que cette manœuvre a entraîné pour celle-ci une atteinte physique se traduisant par une paralysie du plexus brachial la privant de l'usage de son membre supérieur droit ; qu'il ressort également du dossier qu'aucun médecin n'est venu prêter son concours à l'accouchement de Mme X en vue de pratiquer lui-même les gestes médicaux ou chirurgicaux adaptés à la gravité de la situation de cette patiente, en limitant ainsi les risques de voir l'enfant naître atteint d'un tel handicap ; qu'il n'était allégué devant les juges du fond ni qu'une circonstance d'extrême urgence ait fait obstacle à ce que la sage-femme appelle un médecin ainsi qu'elle y était légalement tenue, ni que le médecin de permanence ait été pour des motifs légitimes dans l'impossibilité de se rendre au chevet de Mme X ; que, dès lors, en estimant qu'aucune faute dans l'organisation et le fonctionnement du service ne pouvait être retenue à l'encontre du centre hospitalier général de Pau eu égard aux conditions du déroulement de l'accouchement, la cour administrative d'appel de Bordeaux a entaché son arrêt d'une erreur de qualification juridique ; qu'il y a lieu par suite d'en prononcer l'annulation

2.2. La faute médicale

CE, 29 décembre 1997, M. X., req. n° 158938.

Considérant que M. X... soutient que la cour a commis une erreur de droit en ne jugeant pas que l'échec de l'opération chirurgicale suffisait à lui seul, à établir l'existence d'une faute médicale ; que, cependant, l'échec de l'opération, qui n'est pas contesté, n'est pas en lui-même de nature à établir que M. X... a été victime d'une faute ; que, par suite, la cour a pu légalement répondre à ce moyen que l'absence de succès de l'intervention chirurgicale était sans incidence sur l'existence alléguée d'une prétendue faute médicale ;

Considérant que M. X... soutient que la responsabilité de l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris devait être engagée, même en l'absence de faute ; que, cependant, il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond, que l'état actuel de l'intéressé n'est pas sans rapport avec son état antérieur à l'intervention chirurgicale du 29 novembre 1985 et que cet état, s'il comporte des gênes importantes dans la vie quotidienne du requérant, ne présente toutefois pas un caractère d'extrême gravité ; qu'ainsi, la cour a pu légalement écarter implicitement le moyen tiré de la responsabilité sans faute de l'hôpital ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X... n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué de la cour administrative d'appel de Paris ;

CE, Sect., 14 février 1997, Centre hospitalier régional de Nice, req. n° 133238

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le service de pathologie cellulaire et de génétique du Centre hospitalier régional de Nice s'est borné à annoncer à Mme X... que l'examen auquel il avait procédé "n'avait révélé aucune anomalie détectable par les moyens actuels" et que Mme X... n'a pas été informée du fait que les résultats de cet examen, compte tenu des conditions dans lesquelles il avait été conduit, pouvaient être affectés d'une marge d'erreur inhabituelle ; que, dès lors, M. et Mme X... sont fondés à soutenir que le service spécialisé du Centre hospitalier régional de Nice a commis une faute ;

Considérant qu'il résulte également de l'instruction qu'en demandant qu'il fût procédé à une amniocentèse, Mme X... avait clairement manifesté sa volonté d'éviter le risque d'un accident génétique chez l'enfant conçu, accident dont la probabilité était, compte tenu de son âge au moment des faits, relativement élevée ; que les époux X... avaient ainsi cherché auprès du service spécialisé du Centre hospitalier régional de Nice un diagnostic déterminant quant à l'absence du risque ; que, dans ces conditions, la faute commise par le service de pathologie cellulaire et de génétique du Centre hospitalier régional de Nice avait faussement conduit M. et Mme X... à la certitude que l'enfant conçu n'était pas porteur d'une trisomie et que la grossesse de Mme X... pouvait être normalement menée à son terme ;

Considérant que cette faute, qui rendait sans objet une nouvelle amniocentèse que Mme X... aurait pu faire pratiquer dans la perspective d'une interruption volontaire de grossesse pour motif thérapeutique sur le fondement de l'article L. 162-12 du code de la santé publique, doit être regardée comme la cause directe des préjudices entraînés pour M. et Mme X... par l'infirmité dont est atteint leur enfant ;

CE, 12 décembre 1975, Ministre de la coopération c/ M. X., req. n° 97241.

considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expert y... par les premiers juges que la surdité totale dont est atteint le sieur a... est la conséquence d'un traitement par la Kamychine ordonné le 4 juillet 1966 par le médecin du centre médico-social de la mission française d'aide et de coopération de Bamako ; qu'il résulte également de l'instruction que x... médicament, dont les dangers étaient connus, a été prescrit sans recherche préalable des contre-indications que pouvait présenter le malade ; que x... fait est constitutif d'une faute lourde susceptible d'engager la responsabilité de l'État envers le sieur a... ;

2.3. L'erreur fautive

CE, 19 mars 2003, CHRU Caen, req. n° 195007

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. X..., alors âgé de 23 ans, a ressenti, après avoir soulevé un poids d'environ 50 kilogrammes dans la journée du samedi 14 octobre 1989, une douleur dorsale violente et tenace ; que, devant l'aggravation de cette douleur, il s'est présenté le dimanche 15 octobre vers 4 heures du matin au service des urgences du CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN où des

radiographies ont été effectuées et des calmants lui ont été prescrits ; que, de retour à son domicile, l'intéressé a constaté, dans la soirée, que sa jambe droite se paralysait, ce qui a justifié son transport par le S.A.M.U. au centre hospitalier vers 20 heures ; qu'après son admission et la réalisation de divers examens, il a été transféré au service de rhumatologie vers 23 heures où il a été découvert, le lendemain matin, 16 octobre 1989, atteint d'une paraplégie complète ; qu'une hernie discale dorsale basse en D11-D12 a alors été

diagnostiquée et une intervention chirurgicale pratiquée le même jour vers 18 heures 30, intervention à la suite de laquelle aucune récupération sensitivo-motrice n'a été constatée ;

Sur les conclusions dirigées contre l'arrêt avant-dire droit du 30 décembre 1997 :

Considérant qu'en jugeant que la responsabilité du service hospitalier était engagée à raison d'un retard de diagnostic né, d'une part, de l'erreur du médecin de garde qui n'a pas interprété correctement les symptômes du patient, et d'autre part, de l'incapacité du service des urgences à retrouver les radiographies effectuées le matin même à l'occasion de la première hospitalisation et du défaut caractérisé de surveillance médicale pendant la nuit du 15 au 16 octobre, la cour n'a pas inexactement qualifié les faits ni commis d'erreur de droit en caractérisant les faits de l'espèce à la fois comme établissant une faute médicale et révélant des fautes dans l'organisation du service ;

Considérant qu'en jugeant que le retard de diagnostic a privé l'intéressé de chances réelles de rétablissement ou de récupération même partielle, tout en relevant qu'eu égard au caractère extrêmement aigu de l'évolution des déficits neurologiques observés chez l'intéressé, ce dernier n'aurait eu que des chances limitées mais réelles de récupérer si le diagnostic avait été posé de manière plus précoce, la cour, qui n'a pas entaché son appréciation d'une contradiction de motifs, n'a pas dénaturé les rapports d'expertise qui lui étaient soumis ; que son arrêt est sur ce point suffisamment motivé ;

Considérant qu'après avoir estimé, par une appréciation souveraine des faits, que les fautes commises avaient compromis les chances réelles de rétablissement dont bénéficiait l'intéressé, la cour a pu, en déduire, sans commettre d'erreur de droit, que la réparation intégrale du préjudice incombait au CENTRE HOSPITALIER REGIONAL ET UNIVERSITAIRE DE CAEN ;

CE, 21 oct. 2009, CHG Le Havre, req. n° 311982

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que, le 29 juin 1999, Mme A, qui était dans sa 27ème semaine de grossesse s'est, à la suite de douleurs, présentée à la maternité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU HAVRE ; qu'à l'examen de la patiente le médecin et la sage-femme de permanence ont constaté que la poche des eaux bombait dans le vagin jusqu'à l'orifice vulvaire ; qu'ils en ont déduit que le col de l'utérus était entièrement dilaté et que Mme A était sur le point d'accoucher ; qu'ils ont alors, afin de faciliter l'accouchement, décidé de rompre la poche des eaux pour accéder au col de l'utérus et en ôter le fil de cerclage qui avait été posé à la 15ème semaine de grossesse ; qu'au décours de cette opération, il a été constaté que le col de l'utérus était en réalité à peine dilaté ; que Mme A a donné naissance quelques heures plus tard à un enfant qui souffre de troubles sérieux du fait de sa naissance prématurée ; qu'attribuant le préjudice résultant de la naissance prématurée de leur enfant à une erreur de diagnostic et à une décision inappropriée de rupture de la poche des eaux prise par les praticiens, M. et Mme A ont recherché la responsabilité du CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU HAVRE ; que par un jugement du 6 décembre 2006, le tribunal administratif de Rouen a rejeté cette demande ; que par un arrêt du 30 octobre 2007, la cour administrative d'appel de Douai a annulé ce jugement et condamné le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU HAVRE à verser diverses indemnités aux époux A, en leur nom propre et en celui de leur fils mineur, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ; que le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU HAVRE se pourvoit en cassation contre cet arrêt ;

Considérant qu'en jugeant qu'il résultait de l'instruction et notamment du rapport de l'expert désigné par le tribunal administratif, que si le médecin et la sage-femme qui avaient examiné Mme A avaient exactement diagnostiqué que la poche des eaux était bombée et descendait

dans le vagin de la patiente, ce qui rendait inévitable un accouchement prématuré à bref délai, ils avaient toutefois commis une erreur de diagnostic, que des examens plus approfondis auraient permis d'éviter, en déduisant de cette constatation que le col de l'utérus était dilaté et l'accouchement imminent, la cour administrative d'appel n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis ; qu'en jugeant que cette erreur de diagnostic, qui avait entraîné la décision de déclencher immédiatement l'accouchement, afin d'en faciliter le déroulement, au lieu de chercher à le retarder le temps nécessaire à l'administration d'un traitement susceptible de réduire certaines séquelles d'une naissance prématurée, constituait une faute de nature à engager la responsabilité du service public hospitalier, qui avait fait perdre à l'enfant une chance d'échapper à une partie au moins de ces séquelles, la cour administrative d'appel, qui n'a pas davantage dénaturé les pièces du dossier, n'a pas commis d'erreur de droit ni qualifié inexactement les faits de l'espèce ;

Considérant toutefois que, dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou du traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé, n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter ce dommage ; que la réparation qui incombe à l'hôpital doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminée en fonction de l'ampleur de la chance perdue ; que par suite, en fixant le montant de l'indemnité due par le CENTRE HOSPITALIER GENERAL DU HAVRE à la totalité du préjudice subi par les requérants après avoir pourtant relevé que la faute imputable au service public hospitalier n'avait fait perdre qu'une chance à l'enfant de M. et Mme A d'échapper à une partie des séquelles de sa naissance prématurée, la cour administrative d'appel a entaché son arrêt d'erreur de droit ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER DU HAVRE est fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué, qui est suffisamment motivé, en tant seulement qu'il a déterminé le montant des indemnités dues aux époux A pour leur compte et celui de leur enfant, ainsi qu'à la caisse primaire d'assurance maladie du Havre ;

3. La responsabilité sans faute

- **Les dommages transfusionnels**

CE, Ass., 26 mai 1995, req. n° 143238

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond et qu'il n'est d'ailleurs pas contesté que la contamination de M. Z... Quang par le virus de l'immunodéficience humaine résulte d'une transfusion de sang qu'il a reçue lors d'une intervention chirurgicale pratiquée le 24 janvier 1985 dans le service de cardiologie du groupe hospitalier de la Pitié-Salpêtrière et que le sang a été fourni par le centre de transfusion du même groupe hospitalier, lequel, comme ce dernier, n'a pas une personnalité juridique distincte de celle de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris ; qu'il en résulte que la responsabilité encourue par l'Assistance publique, du fait d'un vice affectant le produit administré, doit être recherchée non sur le fondement des principes qui gouvernent la responsabilité des hôpitaux en tant que dispensateurs de prestations médicales mais, au cas d'espèce, sur la base des règles propres à son activité de gestionnaire d'un centre de transfusion sanguine ;

Considérant qu'en vertu des dispositions de la loi du 21 juillet 1952 modifiée par la loi du 2 août 1961, les centres de transfusion sanguine ont le monopole des opérations de collecte du sang et ont pour mission d'assurer le contrôle médical des prélèvements, le traitement, le

conditionnement et la fourniture aux utilisateurs, des produits sanguins ; qu'en égard tant à la mission qui leur est ainsi confiée par la loi qu'aux risques que présente la fourniture de produits sanguins, les centres de transfusion sont responsables, même en l'absence de faute, des conséquences dommageables de la mauvaise qualité des produits fournis ; qu'ainsi, en jugeant que la responsabilité de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris à l'égard des consorts Z... ne peut être engagée dès lors qu'aucune faute prouvée ou révélée par l'accident n'est établie, la cour administrative d'appel de Paris a fait une inexacte application des règles qui régissent la responsabilité des collectivités publiques ;

- **L'aléa thérapeutique**

CE, Ass., 9 avril 1993, Bianchi, req. n° 69336

Considérant que, par décision du 23 septembre 1988, le Conseil d'Etat statuant au contentieux a rejeté les moyens tirés par M. X... de ce que l'artériographie vertébrale qu'il a subie le 3 octobre 1978 à l'hôpital de la Timone à Marseille n'avait pas été pratiquée par une équipe médicale qualifiée, de ce que le consentement du patient n'avait pas été recueilli et de ce que les soins post-opératoires qu'il a reçus étaient insuffisants ; que ces points ont été définitivement jugés et ne peuvent être remis en cause ;

Considérant qu'il ressort du rapport établi à la suite de la nouvelle expertise ordonnée par la décision précitée du Conseil d'Etat sur les conditions dans lesquelles le produit de contraste nécessaire à l'artériographie a été injecté à M. X..., que ce produit n'a joué aucun rôle dans la survenance des troubles apparus après l'examen, qu'il n'existait aucun indice susceptible de faire soupçonner un risque de réaction ou d'hypersensibilité à l'iode et que, si le compte rendu de l'artériographie n'a pu être retrouvé, les constatations faites aussitôt après l'examen permettent de conclure que la dose totale d'iode injectée n'a pas été excessive par rapport aux normes couramment admises à l'époque ; que l'expert retient comme cause vraisemblable de l'accident une occlusion secondaire à l'artériographie, au niveau de l'artère vascularisant la moelle cervicale, provoquée par une petite bulle ou un petit caillot libérés au cours de l'exploration ou de l'évacuation du produit de contraste, constituant un risque inhérent à ce genre d'examen ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations de l'expert, qui ne sont pas démenties par les autres pièces du dossier, qu'aucune faute ne peut être relevée dans l'exécution de l'artériographie subie par M. X... ;

Considérant, toutefois, que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du malade présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant que le risque inhérent aux artériographies vertébrales et les conséquences de cet acte pratiqué sur M. X... répondent à ces conditions ; que, dès lors, M. X... est fondé à demander l'annulation du jugement attaqué, par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'assistance publique à Marseille ;

CE, Sect., 3 novembre 1997, Hôpital Joseph Imbert d'Arles, req. n° 153686

Considérant que lorsqu'un acte médical nécessaire au diagnostic ou au traitement du patient présente un risque dont l'existence est connue mais dont la réalisation est exceptionnelle et

dont aucune raison ne permet de penser que le patient y soit particulièrement exposé, la responsabilité du service public hospitalier est engagée si l'exécution de cet acte est la cause directe de dommages sans rapport avec l'état initial du patient comme avec l'évolution prévisible de cet état, et présentant un caractère d'extrême gravité ;

Considérant qu'après avoir souverainement constaté que le décès du jeune Y... était intervenu à la suite d'un coma prolongé consécutif à un arrêt cardiaque dont il a été victime au cours de l'opération de circoncision qu'il a subie sous anesthésie générale pratiquée dans les services de l'Hôpital Joseph Imbert, la cour a estimé que le risque inhérent aux anesthésies générales et les conséquences de cet acte pratiqué sur l'enfant Y... répondaient aux conditions susmentionnées ; que, ce faisant, la cour n'a pas commis d'erreur de droit alors même que l'acte médical a été pratiqué lors d'une intervention dépourvue de fin thérapeutique ; que le moyen doit par suite être écarté ;

Considérant que la cour administrative d'appel n'a pas davantage commis d'erreur de droit en décidant, alors même que la responsabilité de l'hôpital était engagée sans faute, d'indemniser la mère de la victime en raison du préjudice moral subi et des troubles dans ses conditions d'existence pendant la période où son fils est demeuré dans le coma et de faire rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône les sommes versées par elle pour les frais d'hospitalisation de l'enfant ;

CE, 13 novembre 2020, req. n° 427750

1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. B..., atteint d'une neurofibromatose de type II, maladie génétique évolutive, a été pris en charge le 18 octobre 2005 à l'hôpital de la Timone de l'Assistance publique - hôpitaux de Marseille (AP-HM), où une radiochirurgie a été pratiquée pour traiter le neurinome dont il était atteint. Immédiatement après cette opération, M. B... a totalement perdu l'audition de l'oreille droite et présenté des acouphènes ainsi qu'une paralysie faciale avec des troubles oculaires, du goût et de la déglutition. Il a demandé au tribunal administratif de Marseille, avec plusieurs de ses ayants droit, de condamner l'AP-HM à l'indemniser de ces divers préjudices. Par un jugement du 27 février 2017, le tribunal administratif, après avoir appelé l'ONIAM en cause, a mis à sa charge le versement de 101 200 euros aux ayants droit de M. B..., lui-même étant décédé en cours de procédure. Sur appel de l'ONIAM, la cour administrative d'appel de Marseille a, par un arrêt du 6 décembre 2018, ramené cette somme à 44 080 euros et condamné l'AP-HM à verser diverses sommes aux ayants droit de M. B. L'ONIAM se pourvoit en cassation contre cet arrêt en tant

qu'il met à sa charge une partie de l'indemnisation des préjudices. Par la voie d'un pourvoi provoqué, les ayants droit de M. B. demandent que, si l'arrêt est annulé en tant qu'il condamne

l'ONIAM à réparer leurs préjudices au titre de la solidarité nationale, il soit également annulé en tant qu'il rejette le surplus de leur appel dirigé contre l'AP-HM ;

2. Il résulte des dispositions combinées du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique et de l'article D. 1142-1 du même code que l'ONIAM doit assurer, au titre de la solidarité nationale, la réparation des dommages résultant directement d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins à la double condition qu'ils présentent un caractère d'anormalité au regard de l'état de santé du patient comme de l'évolution prévisible de cet état et que leur gravité excède le seuil défini à l'article D. 1142-1. La condition d'anormalité du dommage prévue par ces dispositions doit notamment être regardée comme remplie lorsque l'acte médical a entraîné des conséquences notablement plus graves que celles auxquelles le patient était exposé de manière suffisamment probable en l'absence de traitement.

3. En premier lieu, en estimant, ainsi qu'il résulte des termes mêmes de son arrêt, que la radiothérapie pratiquée le 18 octobre 2005 avait, en entraînant de manière immédiate une surdité totale de l'oreille droite, une paralysie de la face ainsi que divers troubles de la sensibilité, du goût, de l'odorat et de la déglutition, compte tenu du jeune âge de M. B..., de son état de santé antérieur et de ce que les neurinomes du type de celui dont il était atteint sont d'évolution lente chez les sujets jeunes, entraîné une survenue prématurée des troubles en question, la cour n'a pas dénaturé les pièces du dossier qui lui était soumis. En en déduisant que, eu égard à cette survenue prématurée, les conséquences de l'intervention devaient être regardées comme notablement plus graves que les troubles auxquels M.B... était exposé de manière suffisamment probable, alors même qu'il aurait été exposé à long terme à des troubles identiques par l'évolution prévisible de sa pathologie et que, par suite, la condition d'anormalité justifiant leur réparation par la solidarité nationale était remplie, la cour a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.

4. En deuxième lieu, si l'ONIAM soutient, à titre subsidiaire, que la cour a entaché son arrêt d'erreur de droit en la condamnant à indemniser des troubles au-delà de la date à laquelle ceux-ci auraient, en l'absence d'intervention, naturellement résulté de l'évolution prévisible de la pathologie, il résulte des dispositions rappelées ci-dessus de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique que celles-ci font obstacle, en l'absence de certitude quant au terme auquel ces troubles seraient apparus en l'absence d'accident, à ce que leur réparation par la solidarité nationale soit limitée jusqu'à une telle échéance.

5. Il résulte de tout ce qui précède que l'ONIAM n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêt attaqué. Son pourvoi doit ainsi être rejeté ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

CE, 25 mai 2022, req. n° 453990

1. Il résulte des pièces du dossier soumis aux juges du fond qu'en vue de faire cesser de violentes névralgies intercostales ayant rendu impossible l'exercice de sa profession de chauffeur routier, M. A... a été opéré en 2014 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Bordeaux d'une hernie discale. Le bon déroulement de l'intervention sur la hernie discale n'a toutefois pas permis d'obtenir la disparition des douleurs. En revanche, lors de cette opération, une lésion accidentelle du nerf grand dentelé gauche a entraîné un décollement majeur de l'omoplate gauche, très invalidant pour l'intéressé. Par un jugement du 26 février 2019, le tribunal administratif de Bordeaux a, à la demande de M. A..., mis à la charge de l'ONIAM le versement de diverses sommes en réparation, par la solidarité nationale, du préjudice ayant résulté de l'intervention chirurgicale. M. A... se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 27 avril 2021 par lequel la cour administrative d'appel de Bordeaux a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté sa demande d'indemnisation, au motif que les conditions d'une prise en charge au titre de la solidarité nationale n'étaient pas remplies.

2. Aux termes du II de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " Lorsque la responsabilité d'un professionnel, d'un établissement, service ou organisme mentionné au I ou d'un producteur de produits n'est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique,

de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire. / Ouvre droit à réparation des préjudices au titre de la solidarité nationale un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à un pourcentage d'un barème spécifique fixé par décret ; ce pourcentage, au plus égal à 25 %, est déterminé par ledit décret ". Aux termes de l'article D. 1142-1 du même code : " Le pourcentage mentionné au dernier alinéa de l'article L. 1142-1 est fixé à 24 %. / Présente également le caractère de gravité mentionné au II de l'article L. 1142-1 un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ayant entraîné, pendant une durée au moins égale à six mois consécutifs ou à six mois non consécutifs sur une période de douze mois, un arrêt temporaire des activités professionnelles ou des gênes temporaires constitutives d'un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à un taux de 50 % (...) ".

3. Il résulte des termes de l'arrêt attaqué que, pour juger que les conséquences de la lésion accidentelle du nerf grand dentelé gauche lors de l'opération du 16 octobre 2014, dont le caractère non fautif n'était pas contesté devant elle, ne remplissaient pas la condition de gravité prévue par les dispositions citées ci-dessus et, par suite, ne pouvaient pas donner lieu à une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d'appel s'est fondée sur ce que, ne répondant à aucune des conditions d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou de gêne constitutive d'un déficit fonctionnel, elles ne pouvaient pas davantage être regardées comme remplissant la condition alternative d'avoir entraîné des arrêts de travail d'une certaine durée. La cour a, en effet, estimé que les arrêts de travail prescrits à M. A... à la suite de cette opération auraient, même en l'absence de l'accident médical non fautif, été nécessaires en toute hypothèse, en raison des douleurs intercostales dont il souffrait et que l'intervention n'avait pas réussi à supprimer.

4. En premier lieu, en jugeant que la seule persistance des douleurs invalidantes qui avaient justifié l'opération, ainsi que les traitements médicamenteux que ces douleurs exigeaient, avaient à eux seuls justifié les arrêts de travail accordés à M. A..., la cour a porté sur les pièces du dossier qui lui étaient soumis une appréciation souveraine, exempte de dénaturation et n'a pas commis d'erreur de droit.

5. En second lieu, en déduisant de cette appréciation que, alors même que la lésion du nerf grand dentelé gauche aurait pu avoir, à elle seule, pour conséquence d'entraîner des arrêts de travail de la durée requise par les dispositions de l'article D. 1142-1 du code de la santé publique cité ci-dessus, cet accident médical ne pouvait, en l'espèce, être regardé comme ayant entraîné des arrêts de travail au sens de ces dispositions et qu'ainsi ses conséquences ne remplissaient pas la condition de gravité requise pour une indemnisation au titre de la solidarité nationale, la cour administrative d'appel a exactement qualifié les faits qui lui étaient soumis et n'a pas commis d'erreur de droit.